促进Plt不可逆聚集的关键:ADP和TXA2

（3）抗血小板

①环氧化酶 COX-1 抑制剂（TXA_2 合成减少）阿姨

阿司匹林	抗血小板的基石，首次负荷量 150-300mg、维持量 75-100mg
吲哚布芬	适合胃肠道出血或消化性溃疡等阿司匹林不耐受者

②P_2Y_{12} 受体拮抗剂（血小板 ADP 受体拮抗剂）：支架植入后加用（2 个格格）

替格瑞洛	首次负荷量 180mg、维持量 90mg 作用更强
氯吡格雷	CYP2C19 慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱 进入体内后必须被肝代谢后才有活性

肝内的一种专门代谢药物的酶

合并了急性冠脉综合征:LDL-C降至1.4mmol/l以下
没有合并ASCVD降低LDL-C<2.6mmol/l(爱点肉)

（4）降脂：首选主要降低 LDL-C＜1.8mmol/L（一点吧）

他汀类	HMG-CoA 还原酶抑制剂：主要降胆固醇、也可降甘油三酯 合成胆固醇的关键酶
依折麦布	胆固醇吸收抑制剂：他汀类效果不佳可联用（一折卖不抑吸收）

注意：主要降甘油三酯的是贝特类

稳定型心绞痛无诱因不发作:斑块也是稳定不会破的

3.血运重建（经规范用药后无效可行）

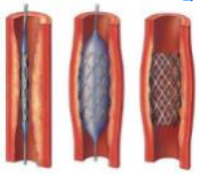
①经皮冠脉介入术 PCI：经皮球囊冠脉成形术 PTCA、冠脉支架植入术等。支架内血栓和再狭窄等影响疗效

②冠脉旁路移植术 CABG：取患者的大隐静脉或桡动脉“搭桥”，适合左主干合并 2 支以上病变、多支病变合并糖尿病、病变严重扭曲伴重度钙化

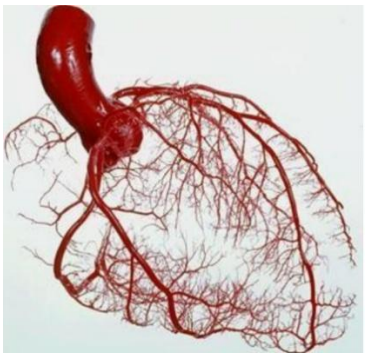
感性认识:很严重时做手术



球囊把血管撑开时会损伤血管内皮→内皮下胶原暴露就会激活血小板→加替格瑞洛/氯吡格雷



（五）稳定型心绞痛的鉴别诊断



1.X 综合征/微血管性心绞痛

①女性多见　运动诱发心肌缺血 VS支气管激发试验

②心电图负荷试验阳性，冠脉造影无狭窄且无冠脉痉挛

③冠脉微循环不良，预后好

2.心脏神经官能症　功能性疾病

①多见于青壮年、ttsx 更年期女性

②与焦虑、紧张、精神创伤等有关

③胸痛不明显，多为几秒钟的刺痛或几小时的隐痛，部位可经常变动

④常伴叹息样呼吸、心悸、头晕、失眠等其它神经症状

⑤症状多于疲劳之后出现、而非疲劳当时，硝酸甘油无效或 10 多分钟后才“见效”

VS心绞痛在疲劳当时出现(耗氧增加)　自己好了

三、不稳定型心绞痛

（一）冠状动脉内是不稳定斑块

不稳定斑块发生破裂、糜烂、侵蚀，继发血栓形成、微血管栓塞、冠脉痉挛等

TXA2(促进血小板聚集、促进血管收缩)

根据堵塞严重程度:不稳定心绞痛→非ST段抬高型心梗→ST段抬高型心梗→猝死